Protocolo de primera sesión

Guía estructurada para la entrevista de evaluación inicial.

Objetivos

1. Establecer la alianza terapéutica.
2. Explicar el encuadre, la confidencialidad y sus límites, y obtener el consentimiento informado.
3. Recoger el motivo de consulta y la historia del problema.
4. Valorar el contexto biopsicosocial y el riesgo.
5. Acordar objetivos preliminares y el siguiente paso.

Estructura orientativa (60 min)

Bloque	Contenido	Tiempo
Bienvenida y encuadre	Presentación, duración y frecuencia de las sesiones, honorarios, confidencialidad y sus límites, consentimiento informado.	5 min
Motivo de consulta	¿Por qué viene ahora? ¿Qué espera del proceso?	10 min
Historia del problema	Inicio, evolución, factores precipitantes y de mantenimiento, intentos de solución.	20 min
Contexto vital	Situación familiar, laboral y social; salud física, medicación, consumo de sustancias; antecedentes psicológicos.	10 min
Riesgo y cribado	Ideación suicida o autolesiva, riesgo para terceros. Escalas si procede (PHQ-9, GAD-7).	5 min
Cierre	Devolución breve, objetivos preliminares, tareas si procede y próxima cita.	10 min

Preguntas orientativas

Área	Preguntas
Problema actual	¿Cuándo empezó? ¿Qué estaba pasando en su vida entonces? ¿Le había ocurrido antes?
Impacto funcional	¿Cómo afecta a su trabajo o estudios, relaciones, ocio y sueño?
Intentos previos	¿Qué ha probado? ¿Qué le ha funcionado, aunque sea un poco? ¿Ha estado en terapia antes?
Motivación	¿Qué le ha llevado a pedir ayuda ahora? ¿Cómo sabría que el proceso le está sirviendo?
Recursos y apoyo	¿Con quién cuenta? ¿Qué se le da bien? ¿Qué le ayuda en los momentos difíciles?
Riesgo	«A veces, cuando alguien se siente así, piensa que no merece la pena vivir. ¿Le ha pasado a usted?»

Uso profesional. Material de apoyo: no sustituye el juicio clínico ni la formación específica en cada técnica o instrumento.

Lista de comprobación al cerrar

Hecho	Elemento
	Consentimiento informado firmado (ver PRO-11).
	Datos de contacto y de emergencia recogidos.
	Riesgo explorado y documentado.
	Escalas de línea base aplicadas, si procede.
	Objetivos preliminares acordados con el paciente.
	Próxima cita fijada.

Uso profesional. Material de apoyo: no sustituye el juicio clínico ni la formación específica en cada técnica o instrumento.